下壁心筋梗塞に合併した心室中隔穿孔の一症例

◎市川 隼也[1)]、山中 良之[1)]、中西 繁夫[1)]、林 美和[1)]、石河 智子[1)]、藪田 憲一[1)]、上阪 浩矛[1)]
三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院[1)]

【はじめに】心室中隔穿孔（VSP）は、心筋梗塞の機械的合併症において全体の約 0.2%と頻度が低く、内科的治療予後が不良な病態のため、早期発見と外科的修復が重要である。また前壁中隔梗塞では心室中隔心尖部に生じるのに対して、下壁梗塞では心室中隔基部に生じることが多い。心室中隔基部の VSP は解剖学的に複雑な形態を呈しやすいため、手術難易度が高いとされる。今回、心エコーにて発見された、下壁梗塞後の心室中隔基部に生じた VSP に対し、外科的修復が行われた一例を経験したため報告する。

【症例】60 歳代　男性

【主訴】胸部不快感、軽労作呼吸苦

【既往歴】高血圧・糖尿病・左下肢閉塞性動脈硬化症

【現病歴】20xx年5月初旬、胸部不快感を自覚し、その3週間後、軽労作時の呼吸困難感を訴えた。他院において両側胸水貯留、心拡大を認めたため、当院に救急搬送された。

【身体所見】BP 133/70mmHg、HR 120回/分、SpO_2 97%

【検査所見】トロポニンI 279 pg/ml、BNP 1783.9 pg/ml、 CK 143 U/I

【心電図所見】Ⅱ、Ⅲ、aVF 誘導で ST 上昇、陰性 T 波

【経過】入院時心エコー所見は、心室中隔基部に心室瘤、菲薄化を認めたが、VSP は認めず、Apical～Base Inferior は severe hypokinesis～akinesis であり、Modified Simpson 法：EF 56.3%であった。入院翌週、収縮期心雑音を認めたため再度心エコー検査を実施すると、心室中隔基部の心室瘤に VSP を認めた。穿孔径φ23mm、LV to RV シャント血流速は 3.5m/sec、QP/QS は 2.1 であった。VSP 発覚翌週、VSP パッチ閉鎖術、三尖弁形成を行った。術後は経過良好で、術後リハビリを継続中である。

【考察】本症例の VSP は下壁梗塞に合併した希少な例であった。下壁梗塞に生じる VSP は心室中隔基部に発生する頻度が高い報告があり、本例もその傾向と一致した。

【結語】今回我々は心筋梗塞の経過観察中に発症した心室中隔基部の VSP に、心エコー検査が有用であった一例を経験した。心室瘤を認めた場合、VSP を念頭に置いて心エコー検査による経過観察が重要であると思われた。

連絡先－0598-21-5252(内線 :2875)